

Historial Clinico - P003

Psiquiatria - Dr. Francisco Morales Jimenez - Motril (Granada)

1. Datos del paciente

ID Paciente	P003
NHC	NHC-2019-011290
Nombre completo	Maria Jose Martinez Aguilar
Sexo	Mujer
Fecha nacimiento	23/07/1975
Edad	50 anos
DNI	52.890.134-W
Telefono	667 321 854
Municipio	Motril (Granada)
Medico responsable	Dr. Francisco Morales Jimenez
Especialidad	Psiquiatria

2. Antecedentes personales

- Trastorno bipolar tipo I, episodios multiples, actualmente en remision parcial (diagnostico 2003, CIE-10: F31.7)
- Cuatro hospitalizaciones por episodios maniacos (2003, 2008, 2015, 2021)
- Ultimo episodio maniaco con sintomas psicoticos en febrero 2021 (ingreso 22 dias)
- Episodios depresivos intercurrentes graves (ultimo episodio depresivo con características melancolicas en 2023)
- Hipotiroidismo secundario a litio (diagnostico 2016)
- Diabetes mellitus tipo 2 (diagnostico 2019)
- Alergia a penicilina y derivados

Antecedentes familiares: Madre: trastorno bipolar tipo II, en tratamiento con valproato. Abuelo materno: 'crisis nerviosas' recurrentes no diagnosticadas formalmente, posible bipolaridad. Padre: hipertension arterial, sin antecedentes psiquiatricos. Hija de 24 anos: trastorno depresivo mayor diagnosticado recientemente.

3. Historia clinica actual

Paciente de 50 anos con trastorno bipolar tipo I diagnosticado a los 28 anos tras un primer episodio maniaco grave con sintomas psicoticos (grandiosidad delirante con conviccion de haber sido elegida para una mision divina, disminucion de la necesidad de sueno a 1-2 horas/noche durante 10 dias consecutivos, verborrea incoercible, hiperactividad desorganizada y conductas de riesgo con gastos descontrolados superiores a 20.000 euros en joyerias y agencias de viajes en una semana). Ha presentado cuatro episodios maniacos que requirieron hospitalizacion y seis episodios depresivos documentados de gravedad variable. El ultimo episodio maniaco (febrero 2021) curso con ideacion megalomaniaca, logorrea, irritabilidad extrema con heteroagresividad verbal hacia su marido, hipersexualidad inadecuada y alucinaciones auditivas congruentes con el estado de animo ('voces que le decian que era invencible'). Tras estabilizacion se ajusto tratamiento a litio mas valproato mas quetiapina. En 2023 presento episodio depresivo grave con características melancolicas: anhedonia absoluta, despertar precoz a las 4 de la mañana, perdida de 9 kg en 7 semanas, enlentecimiento psicomotor grave e ideacion de muerte recurrente sin plan, que remitió tras anadir lamotrigina. Actualmente en remision parcial: eutimia predominante con ciclacion subumbral residual consistente en oscilaciones leves del estado de animo cada 2-3 semanas, generalmente hacia la vertiente depresiva, de 2-3 dias de duracion y de intensidad insuficiente para cumplir criterios de episodio. Buena adherencia terapeutica actual. Jubilada anticipadamente (era profesora de secundaria). Convive con su marido. Niega consumo de toxicos. Sueno de 7 horas con quetiapina.

4. Exploracion

Aspecto general	Consciente, orientada, colaboradora. Buen aspecto general. Contacto cordial y adecuado
Psicomotricidad	Normal. Sin agitacion ni inhibicion. Leve temblor fino postural en manos (litio)
Estado de animo	Eutimico. Afecto reactivo, modulado, congruente. Refiere 'algunos dias como apagada' 2-3 veces al mes, duracion 2-3 dias
Pensamiento	Curso y velocidad normales. Contenido sin ideacion delirante ni autolitica. Preocupada por su hija recién diagnosticada de depresion
Sensopercepcion	Sin alteraciones actuales
Cognicion	Preservada. Quejas subjetivas de memoria: 'se me olvidan palabras', que atribuye al litio. MoCA 26/30 (corte 26)
Conciencia de enfermedad	Buena. Identifica prodromos maniacos (insomnio, aceleracion del pensamiento, gasto impulsivo) y depresivos (despertar precoz, anhedonia)
Peso / Talla / IMC	78 kg - 162 cm - 29,7 kg/m2
Tension arterial	134/82 mmHg
Frecuencia cardiaca	72 lpm, ritmica

5. Tratamiento actual

Farmaco	Posologia
Litio 400 mg	1 comp. en desayuno y 1 comp. en cena (litemia objetivo: 0,6-0,8 mEq/L)
Valproato 500 mg	1 comp. en desayuno y 1 comp. en cena (estabilizador coadyuvante)
Quetiapina 200 mg	1 comp. en cena (estabilizador + hipnotico)
Lamotrigina 100 mg	1 comp. en desayuno y 1 comp. en cena (prevencion de recaidas depresivas)
Levotiroxina 75 mcg	1 comp. en ayunas (hipotiroidismo por litio)
Metformina 850 mg	1 comp. con desayuno y cena (DM2)

6. Resultados de laboratorio

Parametro	Resultado	Ref.	Estado	Previo
Litemia	0,74 mEq/L	0,6-0,8	Normal	0,70 mEq/L
Valproico (nivel)	78 mcg/mL	50-100	Normal	72 mcg/mL
TSH	7,1 mU/L	0,4-4,0	Alto	5,8 mU/L
T4 libre	0,82 ng/dL	0,8-1,8	Normal	0,90 ng/dL
Creatinina	0,95 mg/dL	0,6-1,1	Normal	0,88 mg/dL
Filtrado glom.	78 mL/min	> 60	Normal	84 mL/min
Calcio	10,1 mg/dL	8,5-10,5	Normal	9,8 mg/dL
HbA1c	7,0 %	< 7,0 %	Normal	7,3 %
Glucosa	132 mg/dL	70-110	Alto	128 mg/dL
Hemograma	Normal	-	Normal	Normal
Amonio	Normal	-	Normal	Normal

7. Plan de actuacion

1. Mantener pauta actual: litio 800 mg/dia + valproato 1.000 mg/dia + quetiapina 200 mg/noche + lamotrigina 200 mg/dia
2. Aumentar levotiroxina a 100 mcg si TSH sigue en ascenso en proximo control (derivar a Endocrinologia si TSH > 10)
3. Monitorizacion trimestral: litemia, niveles de valproato, funcion renal, tiroidea y calcio
4. Psicoeducacion: reforzar registro diario de estado de animo y sueno en app (eMoods) para deteccion precoz de ciclacion
5. Terapia interpersonal y de ritmos sociales (IPSRT) quincenal
6. Control de diabetes: derivar a Endocrinologia para optimizacion de tratamiento (HbA1c en limite)
7. Valorar funcion cognitiva en profundidad si quejas subjetivas de memoria persisten: solicitar evaluacion neuropsicologica
8. Revision en consulta en 8 semanas

AVISO: Todos los datos de este documento son completamente ficticios. Generado para el TFG: Sistema RAG de apoyo en salud mental.